

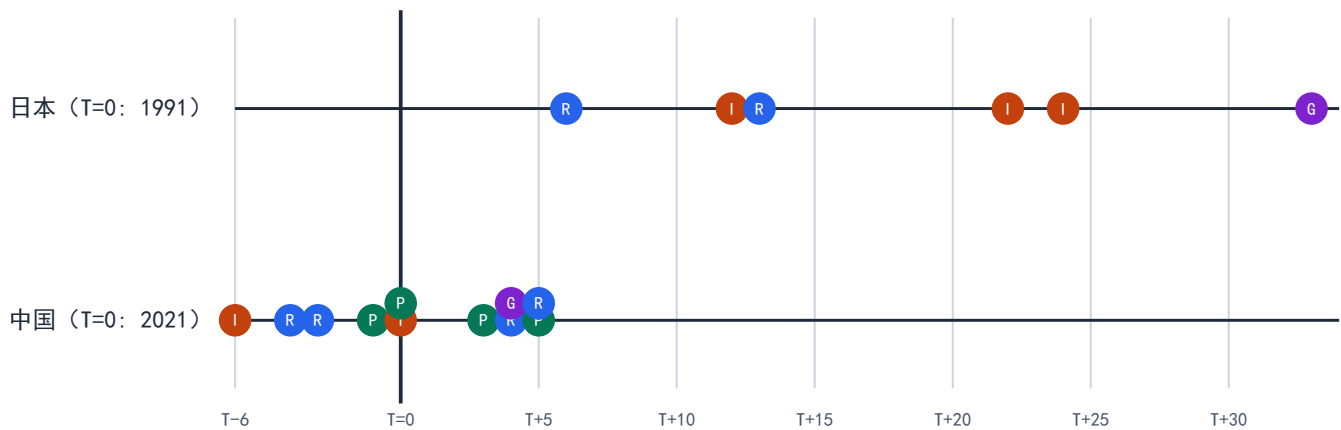
中日医疗器械国产替代与采购政策

相对时间轴比较：以日本 1991、中国 2021 的房价峰值作为 T=0。房价仅用于同步宏观压力起点；比较对象是医疗器械的审评、产业、采购与国际化政策。

核心判断：中国的政策组合更快、更集中，也更直接改变企业的收入分配。日本在 T+0 至 T+15 主要补监管、审评和研发转化；中国在 T-3 至 T+5 已同时启动创新审评、产业链补短板、集采常态化和医院设备更新。

一、对齐后的政策时间轴

标记：R 监管/审评 I 产业/研发 P 采购/需求 G 全球化/本地化



日本的标记主要集中在监管与研发；中国的标记同时覆盖采购/需求端。后者是速度差的关键：采购政策把价格、医院执行、供应稳定性与市场份额置于同一规则框架。

重要边界：时间轴不意味着中国会在 T+12 或 T+33 必然复制日本结果。两国医疗支付制度、人口结构、医院采购制度、企业起点和全球贸易环境都不同。

二、医疗器械集采：政策态度的真正差异

维度	中国：集采/设备更新/监管组合	日本：医保偿还价格与创新准入
首要目的	降低虚高价格、以量换价、保供应，并让医院采购从分散谈判转入规则化竞争。	使特定保险医疗材料的偿还价格反映市场交易，同时通过新功能分类、加算和成本效果评估处理临床增量价值。
竞争单位	注册证产品 + 报价 + 质量 + 产能 + 配送 + 医院约定量。中选后可获得显著确定需求。	功能分类和医保偿还价。不是由国家汇总医院用量，再以中选决定企业份额。
价格机制	价格、承诺采购量、预付和医院考核相互绑定。冠脉支架是首个国家高值耗材集采；官方披露其均价由约 1.3 万元降至约 700 元。	以材料价格调查为基础，按功能分类制定基准材料价格，并可做成本效果价格调整。
对国产替代	正式规则通常要求合规注册、质量、产能和稳定供应，并不以“内资”作为自动中选条件；但本地注册、成本、交付、医院覆盖和供应链能力更容易转成份额。	没有对应的全国集采式本土替代工具。政策更多通过审评、偿还、研发与全球化支持提高本土创新能力。
对创新	创新特别审查和高端器械全周期支持在加速；但进入成熟耗材集采后，企业仍要面对规模成本和价格压力。	新功能分类、改良加算与成本效果调整更直接把“临床增量价值”反映到偿还价；价格压力存在，但不是通过带量中选实现。
政策态度	采购既是支付改革，也是供给侧筛选工具。	采购价格主要是医保支付治理工具；产业竞争力更多由研发、审评与全球化支持推动。

这也是为什么不能把中国集采简单理解成“扶持国产”。它是更强的价格与规模机制：外资可以中选，但原有高价、低量、弱本地供应的商业模式会被系统性压缩。

三、相对年份中的关键节点

相对年	日本	中国
T-6 至 T-1	无与中国创新器械绿色通道、集采启动完全对应的单一政策簇。	2015 制造升级语境；2017 审评改革；2018 创新医疗器械特别审查；2020 冠脉支架集采。
T=0	1991：宏观泡沫破裂，但医疗器械政策尚未出现集中式产业与采购重构。	2021：十部门《“十四五”医疗装备产业发展规划》与高值耗材集采常态化框架并行。
T+3 至 T+5	1994-96：药事法修订与审评制度演进；仍以监管能力建设为主。	2024：医院影像、放疗、远程诊疗、手术机器人设备更新；2025：高端器械全周期监管优化和外资本地生产便利化；2026：支架续约、UDI 扩围。
T+12 至 T+13	2003 医疗器械产业愿景；2004 PMDA 成立，整合审评与安全职能。	尚未到达。不能把日本的后续路径机械投射为中国预测。
T+22 至 T+24	2013 再兴战略推动医疗研发“控制塔”；2015 AMED 成立。	尚未到达。真正需要验证的是：集采后是否还保留足够利润池，支持高端研发和全球化。

四、对美国医疗器械公司的含义

公司	核心暴露	政策读法
GE HealthCare	大设备与影像	设备更新会扩大需求，但大型医院采购与本土化供给会把需求增量更多地变成联影、迈瑞等本土厂商的竞争场，而不是外资的自然增长。
Intuitive Surgical	手术机器人	设备更新和临床扩容是顺风，但不是独占利好。中国政策更容易把设备购置、服务能力和本地竞品放到同一招标/医院预算约束下比较。
Medtronic	高值耗材	与集采直接相关。核心问题不是“外资能否参与”，而是成熟品类价格重构后，能否靠临床差异化、渠道、组合产品与新品维持利润池。
Danaher / Thermo Fisher	IVD、工具、生物工艺	直接集采暴露较低或仅局部。更主要的是医院/科研资本开支、国产中低端替代和中国客户的供应链本地化。

投资上的正确问题不是“政策是否支持国产”，而是：在价格下降后，谁能以更低成本、更稳定供应、更好的临床证据和更强服务网络拿到规模，并把规模转回研发与全球化？这正是中国与日本在医疗器械政策结构上的最大差异。

五、官方来源与口径

[CN-1] 工信部等，《“十四五”医疗装备产业发展规划》及解读，2021：首个国家级医疗装备产业规划，提出补短板、高端设备和国际竞争力。

[CN-2] 国家医保局，冠脉支架集采配套措施，2020；高值耗材集采指导意见相关答复，2021：带量、预付、医院激励约束及公平参与框架。

[CN-3] 国务院，国发〔2024〕7号，2024：设备更新点名医学影像、放疗、远程诊疗、手术机器人。

[CN-4] 国家药监局，2025年第63号、2025年第30号：高端器械全生命周期监管支持；进口器械境内生产优化。

[CN-5] 国家药监局等，2026年第21号；国家医保局，2026年支架第二轮接续采购：UDI 扩围与集采常态化。

[JP-1] 日本厚生劳动省，《医疗器械产业愿景》，2003；PMDA 官方历史，2004：产业战略与审评安全职能整合。

[JP-2] 日本 AMED 官方历史，2013–2015：医疗研发“控制塔”与 AMED 成立。

[JP-3] 日本厚生劳动省，《特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準》，2022；材料价格调查：以功能分类、市场价格与成本效果调整治理偿还价。

[JP-4] 日本经济产业省，《医疗器械产业愿景2024》：全球扩张与 AI 医疗器械为重点。

注：本报告将 1991 / 2021 作为相对时间轴 T=0，是分析框架而非对房价或宏观结果的因果判断；所有政策判断均以官方文本为准。